

# 내시경실 심정지 응급 플로우차트

진정 내시경 중 의식·호흡·맥박 소실 시 즉시 시행 · i-gel supraglottic airway 기준



## 즉시 시행 6단계

- 1 인지 · 호출 (≤10초) — "코드 블루"**  
내시경·mouthguard 즉시 제거 · 좌측위 → supine 전환 · CPR board 확보 · suction 준비 · 직원 분담: 압박자 / 환기자 / 약물 / 기록 / 119 호출
- 2 흉부압박 즉시 시작 — 100-120/min · 깊이 5-6 cm**  
Full chest recoil 보장 · 2분마다 교대 · hands-off time <10초 · ETCO<sub>2</sub> <10 mmHg면 압박 질 점검
- 3 리듬 확인 → 제세동 (필요 시)**  
AED 패드 부착 · 즉시 분석 · shock 후 리듬 재확인 없이 압박 즉시 재개

### SHOCKABLE

#### VF / pVT

Biphasic 200 J 단일 충격 → 즉시 압박 재개 → 2분 후 리듬 재평가

### NON-SHOCKABLE

#### PEA / Asystole

제세동 금지 · 압박 + Epi 1mg q3-5min 지속 · 5H 5T 가역 원인 동시 점검

- 4 i-gel 삽입 (Advanced airway) · Size 4 표준 (50-90 kg)**  
Cuff에 수용성 윤활제 · sniffing position · hard palate 따라 단번에 삽입 · 검은 표시선이 치열에 위치할 때 정지 · 압박 중단 없이 ≤10초 · 삽입 후 BVM·FIO<sub>2</sub> 100% · 압박과 비동기 환기 10회/min · ETCO<sub>2</sub> 모니터 · gastric channel로 OG tube 12 Fr 위 감압
- 5 IV/IO 확보 → Epinephrine 1 mg IV q3-5분**  
모든 리듬 공통 · VF/pVT 지속 시 Amiodarone 300 mg → 150 mg (또는 Lidocaine 1-1.5 mg/kg) · NaHCO<sub>3</sub>·Ca·Mg는 routine 비권장 (특이 적응증만)
- 6 5H 5T 가역 원인 동시 점검 — 내시경실 특이**  
Hypoxia 환기 강화 · Toxin 진정제 길항제 (아래 참조) · Hypovolemia(출혈) 수액·수혈 · Tension PTX(EUS·ERCP 후 드물게)

## 진정제 길항제 (Antidote) — 내시경실 특화

### Naloxone

0.4-2 mg IV

Opioid 역전 — fentanyl · pethidine 호흡억제

### Flumazenil

0.2 mg IV

Benzodiazepine 역전 — midazolam · CPR 중 우선순위 낮음, ROSC 후 고려

### Propofol

길항제 없음

지지요법만 — 환기·승압·수액으로 시간 벌기

**즉시 이송 연락** 119 응급의료  
119 위치·증상·CPR 진행 중 명시

상급병원 (인근 종합)  
**한림대동탄성심병원**  
응급실 직통 ☎ \_\_\_\_-\_\_\_\_ (사전 확보)

